PROTOCOLLO 9

Valutazione psicosociale (Asse II)

Misurare l'impatto del dolore e i fattori psicologici associati

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Dolore persistente	10 minuti	Valutazione iniziale e finale

Indicazioni

- ✓ Dolore da oltre 3 mesi
- ✓ Elevato impatto sulla vita quotidiana
- ✓ Ansia o umore basso riferiti

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, con calma, dopo l'esame fisico.

Fisioterapista: accanto al paziente con i questionari.

Esecuzione passo dopo passo



Intensità e disabilità

Valuta intensità e interferenza del dolore nelle attività.



Ansia e umore

Usa strumenti di screening come il PHQ-4.



Parafunzioni

Indaga serramento, digrignamento e abitudini orali.



Restituzione

Condividi i risultati e, se necessario, proponi un invio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Strumenti	scala del dolore, PHQ-4, checklist delle parafunzioni
Tempo	10 minuti
Ripetizione	a fine percorso

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ I fattori psicosociali influenzano la cronicità
- ✓ Usa un linguaggio non giudicante
- ✓ Collabora con lo psicologo quando indicato

Errori da evitare

- ! Saltare l'Asse II nei casi cronici
- ! Interpretare i punteggi come diagnosi psichiatriche
- ! Trascurare il sonno

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario dello stress	Annotare livello di stress e serramento durante la giornata	3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il modello DC/TMD integra Asse I (fisico) e Asse II (psicosociale): entrambi guidano il piano di trattamento.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.